Клинические рекомендации

# Грибковый отит

Конспект для врача-оториноларинголога

| | |
|---|---|
| Коды МКБ-10 | **B37.8** — Кандидоз других локализаций<br>**B44.8** — Другие виды аспергиллеза<br>**B49** — Микоз неуточненный<br>**H60.8** — Другие наружные отиты<br>**H62.2** — Наружный отит при микозах<br>**H66.3** — Другие хронические гнойные средние отиты |
| Пациенты | взрослые, дети |
| Рекомендация | опубликована в рубрикаторе Минздрава 25.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года |
| Разработчик | Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов |
| Полный текст | cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/304_2 |

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

## Оглавление


**1. Основные положения** 3

**2. Клиническая картина и классификация** 3

2.1 Определение и формы 3

2.2 Возбудители и предрасполагающие факторы 3

2.3 Жалобы и анамнез 4

2.4 Картина по возбудителю 4

**3. Диагностика** 5

3.1 Отомикроскопия 5

3.2 Микологическое исследование отделяемого из уха 6

3.3 Анализы крови 6

**4. Лечение** 7

4.1 Наружный грибковый отит 7

4.2 Грибковый средний отит и микоз послеоперационной полости 7

4.3 Туалет уха 8

4.4 Хирургическое лечение 8

4.5 Немедикаментозное лечение 8

**5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации** 9

5.1 Показания к госпитализации 9

5.2 Диспансерное наблюдение и профилактика 9

**6. Источник и актуальность** 9

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 9

## 1. Основные положения

- Отомикоз: грибковое поражение кожи ушной раковины, наружного слухового прохода, барабанной перепонки, барабанной полости или послеоперационной полости среднего уха. Основные возбудители — плесневые грибы Aspergillus и дрожжеподобные Candida. Течение хроническое, рецидивирующее.
- Диагноз устанавливается только после выявления возбудителя: микроскопия и посев отделяемого из уха на грибы. Однократный отрицательный результат микоз не исключает.
- Лечение: тщательный туалет уха врачом и местные противогрибковые аппликации, при среднем отите и микозе послеоперационной полости — также противогрибковые препараты внутрь. Критерий излечения: клиническое выздоровление в течение месяца и отрицательное микологическое исследование.
- Госпитализация:
  1. осложнённый грибковый средний отит;
  2. лабиринтит;
  3. невозможность ежедневного туалета уха;
  4. нет эффекта амбулаторного лечения наружного грибкового отита **за 5–7 дней**.

## 2. Клиническая картина и классификация

### 2.1 Определение и формы

1. грибковый наружный отит: плесневые или дрожжеподобные грибы на коже ушной раковины, стенках наружного слухового прохода, барабанной перепонке;
2. грибковый мирингит: плесневые грибы на барабанной перепонке;
3. грибковый средний отит: плесневые и дрожжеподобные грибы в барабанной полости;
4. микоз послеоперационной полости среднего уха.

Синоним: отомикоз (ОМ).

**Классификация**

1. по локализации: наружный грибковый отит, грибковый мирингит, грибковый средний отит, грибковый средний послеоперационный отит;
2. по возбудителю: плесневой, дрожжеподобный, смешанный;
3. по течению: хронический.

### 2.2 Возбудители и предрасполагающие факторы

Основными возбудителями являются плесневые грибы рода Aspergillus и дрожжеподобные грибы рода Candida. Все возбудители условно-патогенные: заболевание развивается при наличии предрасполагающих факторов.

**Частота возбудителей**

1. Aspergillus: 65% случаев;
2. Candida: 30%;
3. Penicillium, Mucor, Alternaria, Geotrichum, Cladosporium и другие: до 5%;
4. сочетание Aspergillus и Candida: 15%.

Виды: Aspergillus niger, fumigatus, oryzae, flavus и другие; Candida albicans, tropicalis, krusei, glabrata, parapsilosis и другие; Penicillium notatum и другие.

**Предрасполагающие факторы**

1. травма кожи при чрезмерной гигиене слухового прохода с удалением защитной серы;
2. сахарный диабет: глюкоза в ушной сере повышается уже на ранних стадиях;
3. соматические заболевания, нарушение обмена веществ, гиповитаминоз;
4. длительная системная и местная антибиотикотерапия, кортикостероиды;
5. иммунодепрессанты, лучевая терапия.

**Микоз послеоперационной полости**

1. длительное воспаление в полости с повреждением эпителия;
2. травма уха, в том числе операционная;
3. попадание нестерильной воды;
4. влажность, запылённость, производственный контакт с антибиотиками.

Для грибкового отита характерно рецидивирующее течение.

### 2.3 Жалобы и анамнез

**Наружный грибковый отит**

1. жидкие выделения (кандидоз);
2. корочки и пробки в слуховом проходе (аспергиллёз);
3. зуд, боль, заложенность уха;
4. в острой стадии иногда головная боль, лихорадка, болезненность раковины, заушной области и слухового прохода.

Слух не снижен или снижен незначительно по кондуктивному типу.

**Грибковый средний отит**

1. снижение слуха;
2. выделения из уха;
3. периодический зуд;
4. возможны головокружения.

Течение длительное; обострения — выраженная боль, зуд, заложенность, выделения, головная боль, головокружение.

**В анамнезе уточняют**

1. начало и течение болезни, частоту и характер обострений;
2. прежние отиты и микозы другой локализации;
3. прежнее лечение и его эффект;
4. лечение антибиотиками, кортикостероидами, иммунодепрессантами: длительность и интенсивность;
5. производственные и бытовые условия, аллергологический анамнез.

Для отомикоза характерны учащение обострений и слабый эффект стандартного лечения.

### 2.4 Картина по возбудителю

| Возбудитель | Картина |
|---|---|
| **Дрожжеподобные (Candida)** | 1. в процесс может вовлекаться кожа раковины и околоушной области;<br>2. гиперемия, инфильтрация и мацерация кожи слухового прохода, гиперемия барабанной перепонки;<br>3. при среднем отите утолщение слизистой, густое мутное отделяемое; нарушение эпителизации послеоперационной полости;<br>4. беловатое, менее густое отделяемое; на раковине эрозии, легко снимающиеся беловатые налёты; возможен хондроперихондрит. |

| Возбудитель | Картина |
|---|---|
| **Aspergillus** | 1. казеозно-некротические массы;<br>2. инфильтрация сильнее в костном отделе, возможен мирингит;<br>3. беловато-серые наложения с чёрными вкраплениями: «молотый перец», «промокшая газета»;<br>4. Aspergillus glaucus: зеленоватое отделяемое. |
| **Penicillium** | 1. желтоватое отделяемое, иногда как сера, по всему слуховому проходу;<br>2. инфильтрация кожи, сухие корочки и плёнки. |
| **Geotrichum capitatum** | 1. выраженная инфильтрация кожи, мирингит;<br>2. плотные «замазкообразные» серовато-жёлтые массы по всему слуховому проходу. |

## 3. Диагностика

Диагноз основан на комплексе: жалобы, анамнез, физикальное, лабораторное и инструментальное обследование.

### 3.1 Отомикроскопия

**Показания**

1. все пациенты: осмотр наружного слухового прохода, барабанной перепонки, барабанной полости и послеоперационной полости под микроскопом, отоскопом или торцевым эндоскопом.

**Общий признак всех форм**

1. окрашенное отделяемое в слуховом проходе и (или) среднем ухе.

Диагноз «отомикоз» устанавливается только после выявления возбудителя.

Осмотр с увеличивающей оптикой: отоскоп, микроскоп, торцевой эндоскоп.

| Форма | Отоскопические признаки |
|---|---|
| **Кандидоз наружного слухового прохода** | 1. умеренное сужение просвета, сильнее в хрящевом отделе;<br>2. барабанная перепонка гиперемирована;<br>3. отделяемое жидкое, беловатое, творожистое;<br>4. процесс часто переходит на кожу раковины. |
| **Аспергиллёз** | 1. сужение за счёт инфильтрации, сильнее в костном отделе;<br>2. барабанная перепонка почти всегда инфильтрирована, утолщена, без опознавательных контуров; иногда грануляции;<br>3. обильное отделяемое разных оттенков серого, иногда с чёрными точками, холестеатомо- или сероподобное, как промокшая газета. |
| **Пенициллиоз** | 1. процесс в хрящевом отделе, умеренная инфильтрация без полного закрытия прохода;<br>2. барабанная перепонка гиперемирована, иногда эрозирована или выпячена — ложное впечатление перфорации;<br>3. отделяемое оттенков жёлтого, как сера, по всему проходу, с сухими корочками и плёнками. |

| Форма | Отоскопические признаки |
|---|---|
| **Грибковый средний отит** | 1. специфическое отделяемое, цвет и консистенция по виду гриба;<br>2. часто сопутствует наружный отит;<br>3. барабанная перепонка гиперемирована, инфильтрирована, перфорации разного размера;<br>4. слизистая барабанной полости гиперемирована, инфильтрирована, иногда грануляции. |
| **Микоз послеоперационной полости** | 1. эпителизации нет или она резко замедлена;<br>2. стенки прохода гиперемированы, неравномерно инфильтрированы;<br>3. неотимпанальная полость заполнена отделяемым, как при отомикозе другой локализации;<br>4. мелкие кровоточащие грануляции. |

### 3.2 Микологическое исследование отделяемого из уха

**Показания**

1. все пациенты: микроскопия отделяемого на дрожжевые и мицелиальные грибы, посев на дрожжевые и на мицелиальные грибы.

**При хроническом отите обязательно, если**

1. частые обострения (**1 раз в 2 месяца**);
2. противовоспалительная антибактериальная терапия неэффективна;
3. характерная отоскопическая картина микоза.

После лечения — контрольные исследования.

1. материал берут аттиковым зондом или ложкой Фолькмана из глубоких отделов слухового прохода под контролем микроскопа, отоскопа или эндоскопа;
2. помещают между двумя обезжиренными стерильными стёклами, микроскопия при увеличении ×100, ×200, ×400;
3. микроскопия — самый информативный метод, надёжно определяет возбудителя;
4. критерий микоза при посеве: титр грибов **не менее $10^4$ КОЕ/мл**.

Повторное исследование: однократный отрицательный результат не исключает грибковое заболевание, а единичный рост грибов в посеве не всегда означает микоз. Решающее значение — у микологических методов, не у отоскопии.

### 3.3 Анализы крови

**Показания**

1. затяжное и рецидивирующее течение: поиск сопутствующих и фоновых заболеваний.

**Исследования**

1. общий (клинический) анализ крови;
2. биохимия: глюкоза, общий белок, АСТ, АЛТ, креатинин;
3. антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2;
4. антитела к бледной трепонеме;
5. HBsAg (гепатит B), антиген вируса гепатита C.

Поражение уха на фоне системных, в том числе инфекционных, заболеваний: консультация соответствующего специалиста и дообследование.

## 4. Лечение

Всем пациентам лечение начинают с элиминации возбудителя: противогрибковая терапия и тщательный туалет слухового прохода, барабанной или послеоперационной полости. Учитывают прежние эпизоды микоза и местные противогрибковые препараты.

Местную терапию начинают, не дожидаясь результатов посева.

**Схема лечения отомикоза**

| Локализация | Дрожжеподобные грибы | Плесневые грибы |
|---|---|---|
| **Наружное ухо, местно** | нафтифин 1% раствор + клотримазол 1% раствор | нафтифин 1% раствор + хлорнитрофенол 1% раствор |
| **Среднее ухо, местно** | нафтифин 1% раствор + клотримазол 1% раствор | нафтифин 1% раствор + хлорнитрофенол 1% раствор |
| **Среднее ухо, внутрь** | #флуконазол, капсулы | #итраконазол, капсулы |
| **Послеоперационная полость, местно** | нафтифин 1% раствор + клотримазол 1% раствор | нафтифин 1% раствор + хлорнитрофенол 1% раствор |
| **Послеоперационная полость, внутрь** | флуконазол, капсулы | итраконазол, капсулы, или #тербинафин, таблетки (с 3 лет) |

### 4.1 Наружный грибковый отит

**Кандидозный**: 1% раствор #клотримазола + 1% раствор #нафтифина, аппликации.

1. по 5–10 минут 2 раза в сутки, **14 дней**;
2. затем ещё **14 дней** после стихания клинических признаков и (или) до 3-кратного отрицательного анализа.

Возможны также миконазол, натамицин, #эконазол.

**Плесневые грибы**: #хлорнитрофенол + 1% раствор #нафтифина, аппликации на кожу слухового прохода.

1. по 5–10 минут 2 раза в день, **10–14 дней**;
2. затем ещё **14 дней** после стихания клинических признаков и (или) до 3-кратного отрицательного анализа.

**Грибково-бактериальная ассоциация**: комбинированные ушные капли #хлорамфеникол + беклометазон + клотримазол + лидокаин.

1. по 4–5 капель 3–4 раза в день, **10 дней**; детям **с 6 лет**.

### 4.2 Грибковый средний отит и микоз послеоперационной полости

**Candida**: кроме местного лечения — противогрибковый препарат внутрь, #флуконазол в возрастной дозе.

**Плесневые грибы**: итраконазол или тербинафин внутрь; местная терапия как при наружном грибковом отите.

**Дозы противогрибковых препаратов системного действия**

1. #флуконазол: внутрь 50–100 мг 1 раз в сутки, **14 дней**;
2. #итраконазол: внутрь 200 мг 1 раз в сутки, **10–14 дней**;
3. #тербинафин: внутрь 250 мг в сутки, **16 дней**.

Возрастная группа в таблице 2 КР не указана. Детям #флуконазол назначается в возрастной дозировке, конкретная доза в КР не приведена; #тербинафин — **с 3 лет** (таблица 1 КР).

Критерий эффективности: полное клиническое излечение **в течение месяца**, подтверждённое клинической картиной и отрицательным микологическим исследованием.

Общая длительность противогрибковой терапии местного и (или) системного действия, по критериям качества КР, — **28 дней и более**.

1. нафтифин: фунгистатичен к Candida, фунгициден к плесневым грибам, есть противовоспалительный эффект, долго держит концентрацию в коже;
2. хлорнитрофенол: противогрибковое и антибактериальное действие, в высоких концентрациях активен и против Proteus и синегнойной палочки;
3. клотримазол: высокоспецифичен к Candida, преимущественно фунгистатичен.

### 4.3 Туалет уха

**Показания**

1. все пациенты: тщательная очистка уха от отделяемого перед местной терапией.

Только врач: аттиковым зондом и (или) ушным зондом с ватой, смоченной противогрибковым препаратом, или вакуум-экстрактором. Даже небольшое количество грибковых масс заметно удлиняет лечение.

**Особенности**

1. наружный отит: особенно передненижний отдел слухового прохода;
2. средний отит: полностью удалить массы из области перфораций; при больших перфорациях промывание барабанной полости 0,01% раствором бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмония;
3. послеоперационный микоз: очищают всю неотимпанальную полость, особенно задний отдел за шпорой.

Препарат вводят в ухо на турунде: спиртсодержащие капли раздражают слуховой проход, а при среднем отите вызывают резкую боль, отёк слизистой, усугубление мукозита и грануляции. Турунда удлиняет действие препарата.

### 4.4 Хирургическое лечение

**Показания**

1. полипы, грануляции: до медикаментозной терапии удаление или туширование 10% раствором нитрата серебра.

После туширования обязательна обработка местным противогрибковым препаратом, например нафтифином или хлорнитрофенолом.

### 4.5 Немедикаментозное лечение

Физиотерапия не рекомендуется. Следует ограничить воздействие пыли, газов и повышенной влажности; решающее значение имеет предотвращение попадания воды в ухо.

## 5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

### 5.1 Показания к госпитализации

**Показания к госпитализации**

1. осложнённые формы грибкового среднего отита;
2. лабиринтит;
3. невозможность ежедневного адекватного туалета слухового прохода;
4. неэффективность адекватной амбулаторной терапии наружного грибкового отита **в течение 5–7 дней**.

Первичную помощь оказывают врачи общей практики и оториноларингологи первичного звена. Медицинская реабилитация не проводится.

### 5.2 Диспансерное наблюдение и профилактика

**Частота осмотров**

1. все пациенты с грибковым отитом: осмотр оториноларинголога **1 раз в 3 месяца**, при благоприятном течении **1 раз в полгода**, **2 года**.

**Профилактика**

1. правильный туалет слухового прохода и ушной раковины;
2. коррекция гликемии;
3. общеукрепляющая терапия.

**Профилактика рецидивов**

1. наблюдение **6 месяцев**;
2. курс профилактического лечения;
3. раз в неделю **4–6 недель** смазывание кожи слухового прохода нафтифином или хлорнитрофенолом.

Повторные посевы из уха — до микробиологического подтверждения элиминации возбудителя.

## 6. Источник и актуальность

| | |
|---|---|
| Документ | Клинические рекомендации «Грибковый отит» |
| Версия | 2-я, опубликована в рубрикаторе 25.10.2024 |
| Статус | **Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026) |
| Актуализация | По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2027 года |
| Код в рубрикаторе | `304_2` · открыть текст КР ↗ |
| Разработчик | Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов |
| Пациенты | Взрослые и дети |

### 6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Существенных неточностей и противоречий, влияющих на диагностику и лечение, не найдено.